

מכשיר סקשן (Suction)



תמונה 25.12 קטטר סקשן

מכשיר הסקשן הוא מכשיר בצורת אקדח עם מכל איסוף הפרשות. לחיצות נמרצות על ידי המכשיר יוצרות פעולת יניקה מפתח השאיבה שאליו מחובר קטטר הסקשן הגמיש החד-פעמי. המכשיר מיועד לשאיבת הפרשות נוזליות בלבד.

קטטר לשאיבה (גמיש)

אל פיית צינור הסקשן צריכה להתחבר צינורית סטרילית לשאיבה שתוחדר לדרכי נשימתו של המטופל. בערכת החייאה יש (תקנית) 2 גדלים של קטטר לסקשן ומכל גודל יש שני קטטרים; בסך הכול 4 קטטרים: 2 קטטרים מס' 18 (רחבים) ו-2 קטטרים מס' 8 (צרים). בערכת החייאה לתינוקות אפשר למצוא לעיתים קטטר קטן יותר - מס' 6.

החלק הצבעוני שבקצה מחבר את פיית צינור הסקשן לקצהו האחר שחייב להיות בעל פתח מרכזי. יש בקצה כמה פתחים נוספים המאפשרים שאיבה מהירה יותר למקרה שאחד החורים נסתם בזמן שאיבה.

הקטטר לשאיבה מיועד לשאיבה בשתי דרכים:

- 1) דרך פיו של המטופל (בלי להגיע ללוע העליון).
 - 2) דרך טוֹבוֹס. במקרה זה יש להקפיד שקוטר הקטטר לשאיבה לא יעלה על 2/3 מקוטר הטוֹבוֹס שדרכו שואבים. הוא נמצא בניידת נט"ן בלבד.
- למבוגרים - משתמשים בקטטר לסקשן הגדול ביותר, מס' 18, לשאיבה מהפה ומהטוֹבוֹס.
 - לילדים - גם כן משתמשים בקטטר מס' 18 בשאיבה מהפה ובקטטר 8 לשאיבה מהטוֹבוֹס.
 - לפעוטות ותינוקות משתמשים בקטטר 8.

הטכניקה הנכונה לביצוע השאיבה למטופל

המכשיר מיועד לשאיבת הפרשות עדינות בלבד. לשם סילוק הפרשות גסות (גושים או חתיכות) מטים את כל גוף המטופל הצידה ומוציאים את ההפרשות ביד. לשם ביצוע שאיבה עם המכשיר אין צורך להטות את הנפגע על צידו. כך שאם הנפגע שוכב על הארץ יש להשאירו על הגב תוך שמירה על הטיית ראש לאחור.

ציוד שיש להכין כדי לשאוב הפרשות

- מכשיר הסקשן
- קטטרים לסקשן
- ציוד להנשמה - שיהיה בהישג יד
- כלי המכיל מים רגילים (רצוי כלי עם בסיס רחב) - לשטיפת הקטטר בגמר השאיבות

שלבי ביצוע שאיבה למטופל מונשם

- 1) מוודאים שהמטופל מונשם ומחומצן לפני ביצוע סקשן.
- 2) שומרים על תנוחת המטופל ומוציאים את מנתב האוויר מפיו.
- 3) מחדירים את קטטר השאיבה בעדינות לפיו או לאפו של המטופל ללא הפעלת הסקשן.
- 4) מתחילים ללחוץ על ידית המכשיר בקצב אחיד ומהיר תוך הטיית הקטטר למקום שבו יש הפרשות.
- 5) שואבים למשך 5-6 שניות, לא יותר, גם אם למטופל יש עוד הפרשות. הסיבה לכך היא שצריך להספיק לחזור ולחמצן את המטופל תוך 10 שניות מזמן הפסקת ההנשמה. פרק זמן זה כולל החדרה חוזרת של המנתב והרכבת מסכה. ביצוע סקשן מוריד את מתח החמצן בדמו של המטופל.
- 6) לאחר גמר השאיבה שואבים מעט מים מהכלי שהוכן מראש כדי למנוע סתימה של המכשיר מהפרשות.
- 7) לאחר שטיפת הקטטר חוזרים ומנשימים (כולל החדרת מנתב אוויר) למשך 3 דקות לפחות עם מרב ריכוז החמצן האפשרי.

**אין להפסיק את הנשמת המטופל ליותר מ־10 שניות לשם ביצוע שאיבה
(גם אם נותרו עוד הפרשות)**

חשוב להוציא מנתב אוויר לפני ביצוע שאיבה:

- 1) כדי לראות אם המנתב עצמו אינו חסום בהפרשות
- 2) לשם ביצוע שאיבה טובה יותר (בעיקר תחת הלשון)
- 3) כדי לקצר את זמן השאיבה
- 4) בשל הימצאות המנתב בפיו של המטופל אפשר להשתמש בקטטר גדול יותר

שאיבה אצל מטופל מחוסר הכרה, נושם (שאינו זקוק להנשמה)

- 1) שומרים על תנוחת המטופל ומוציאים את מנתב האוויר (אם היה בפיו)
- 2) שואבים בעדינות מפיו ואפו של המטופל - לפי כמות הפרשות ובלבד שהשאיבה לא תאריך יותר מדקה אחת ברציפות
- 3) מעשירים את המטופל בריכוזים גבוהים של חמצן לפני ואחרי ביצוע סקשן

« שאיבת הפרשות, בעיקר דרך טובוס, גורמות להיפוקסמיה (hypoxemia) ירידת רמת החמצן בדם

« הגבלת זמן נכונה תקטין את הפגיעה בריכוז החמצן בדמו של המטופל

« מבצעים סקשן גם סביב הטובוס - בתוך חלל הפה

ניקוי והכנת המכשיר לפעולה חוזרת

לאחר גמר הטיפול במטופל מנקים בתמיסת כלור את כל חלקי המכשיר, שוטפים במי ברז ומייבשים כדי שיהיה יבש ונקי, מוכן להפעלה חדשה.

מכל חמצן



תמונה 25.13 מכל חמצן

חמצן הוא אחד מהטיפולים הראשונים הניתנים למטופל או לפצוע. כדי להשתמש בו בדרך נכונה ובטוחה יש להכיר תחילה את נתוני המערכות העומדות לרשות הצוות הרפואי.

נפחים של מכלי חמצן

- (1) מכל חמצן גדול - H - נפחו 20 ליטר; נמצא בנט"ן, באמבולנס רגיל, במתקני מילוי ובחלק מהתארים
- (2) מכל חמצן נייד גדול - E - נפחו 4.2 ליטר; נמצא במסוקים
- (3) מכל חמצן נייד - D - נפחו 2.4 ליטר; נמצא בנט"ן ובאמבולנס רגיל
- (4) מכל חמצן נייד קטן - נפחו 1.5 ליטר; נמצא באופנועי הכוננים

בכל מכל דחוס חמצן עד לחץ אטמוספרי מרבי של כ-150 אטמוספרות.

הנוסחה לחשב את כמות החמצן הנמצאת במכל ולכמה זמן הוא יספיק:

$$\frac{\text{לחץ אטמוספרי נוכחי} \times \text{נפח המכל}}{\text{זרימת החמצן (ליטר/דקה)}} = \text{משך זמן השימוש (בדקות)}$$